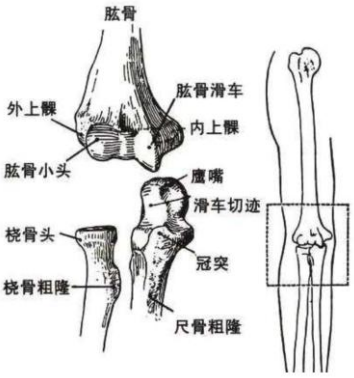
（五）肱骨髁上骨折（不是内上髁、外上髁骨折）

1.解剖基础：肱骨干与肱骨髁轴线有 **30-50°**的前倾角（01 要我扇我）



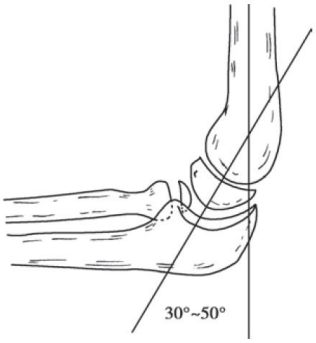


图 61-12　肱骨干与肱骨髁之间的前倾角



2.多见于**＜10 岁**

可以与周围神经损伤结合一起考:如正中神经损伤会出现猿手、大鱼际肌萎缩、1指对掌障碍、123指屈曲障碍;尺神经损伤:手指内收外展障碍、4,5指爪形手、Froment征、夹纸实验阳性;桡神经损伤:垂腕垂指等

3.**伸直型肱骨髁上骨折常见**

①手**掌**着地，**近折端向前下、远折端向后上移位**，肘前方扪及断端，肘向后突出处于半屈位

②早期可损伤肱动脉、正中神经、尺神经或桡神经，可引起前臂**骨筋膜室综合征**（水肿、血肿→压力急剧增高）——**高度肿胀、5P 综合征**（疼痛或转为无痛）、动脉搏动减弱消失。并发骨筋膜室综合征时**立即切开骨筋膜室减压（预防缺血性肌挛缩）**

痛骂白无常

神经被压烂了　易发生于前臂、小腿　eg.急性动脉栓塞

③晚期可并发骨化性肌炎/创伤性骨化（间叶组织的化生）、肘内翻畸形（提携角＜0°）、肘外翻畸形（提携角＞15°）

④手法复位+外固定（后侧石膏托屈肘位）　儿童的骺板因骨折被破坏,导致干骺端长歪了

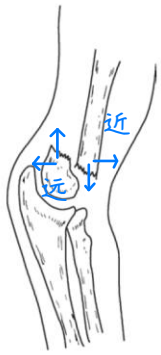


图 61-13　伸直型肱骨髁上骨折典型移位



图 61-14　骨折远折端向尺侧移位

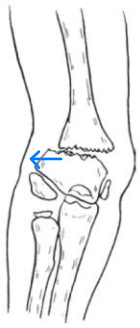


图 61-15　骨折远折端向桡侧移位

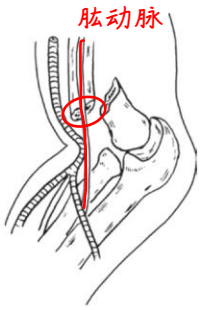


图 61-16　骨折近折端向前移位损伤肱动脉

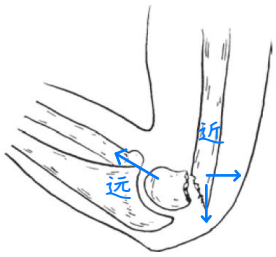


图 61-17　屈曲型肱骨髁上骨折典型移位

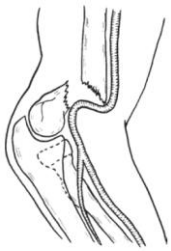
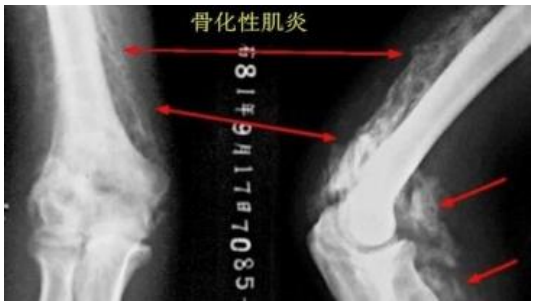
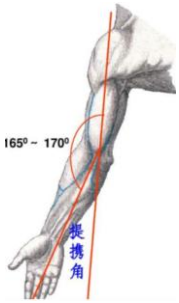


图 60-13　伸直型肱骨髁上骨折造成肱动脉损伤





4.屈曲型

①肘后方着地，近折端向后下、远折端向前移位（α 第一笔是伸直型、第二笔是屈曲型）

②近折端易刺破皮肤（开放性骨折）导致感染

